

07 - 2-examen de l'épaule sono maker

Alors, aujourd'hui nous allons voir l'épaule et le rachis, d'accord ? Je demande toute votre attention. Chaque particularité, chaque région a sa particularité. Qui peut me dire la particularité de l'épaule ? En partant de l'anatomie, en partant de la restauration alimentaire la plus fréquente, très mobile, très bien, très très bien, c'est important, dépendant, d'accord ? Autre particularité de l'épaule, ton blesse articulaire, ça c'est bien, très très bien, on ne compte pas une seule articulation, mais il y a trois articulations.

Dernière particularité de l'épaule, la rotation, la mobilité, superficielle, c'est bien, très très bien, ça veut dire quoi ? Deux temps de blanc, et les instants du petit bois. Installez-vous en silence, ça veut dire ? Celui-ci c'est facilement, il n'y a pas eu d'ambulance. Très très bien.

Alors l'articulation de l'époque, principale de l'époque, comment on l'appelle ? Il est long, il est numéral, se caractérise par les surfaces articulaires, comment on l'appelle ? La qualité des bruits par rapport à la tête, très petite, et il ne couvre que le un tiers, le un tiers de la tête numérale, c'est pourquoi on parle de, il est peu flamboyant, ça veut dire que c'est facile de se luxer. Alors la luxation s'il est trop mal vu, mais un deuxième grand caractéristique de l'épaule c'est que, c'est-à-dire la tête de l'articulation proprement dite, elle n'est pas fréquente par rapport à la pathologie tendue. C'est pourquoi nous aurons comme objectif aujourd'hui, bien sûr le savoir examiner l'épaule, ce qu'on avait vu, la mobilité active, la mobilité passive, une de vos camarades hier m'a demandé la contraire, et je ne voulais pas vous dire en vrac les choses, on va insister aujourd'hui sur l'épaule, pourquoi ? Parce que vu la fréquence de la pathologie tendue, il faut qu'il y ait la longueur à l'articulation de l'épaule.

Est-ce que vous vous souvenez hier, quand on vient de viser, quand on vient de regarder, vous me donnez la douleur au niveau de l'épaule, donnez-moi un exemple, le cœur, attention, ça c'est un réflexe, un sujet d'un certain âge, il tient l'épaule, attention, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un impact de l'épaule, d'accord ? Il commence à maigrir, attention, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une néoclative de latex ? Ainsi de suite, d'accord ? Alors, il faut savoir relier la douleur à l'articulation proprement dite de l'épaule, et nous allons insister sur les 4 types de tabou, parce qu'on va voir, même pour une douleur, il y a les gens qui disent, j'ai mal quand je fais quelques mouvements, c'est différent de la douleur qui continue, c'est différent de l'épaule tendante, d'accord ? Alors là, ce sont les 4 différents types de tabou. Bien sûr, qui dit tendante, est-ce que vous vous rappelez le nom des tendantes ? Ça date de combien la famille ? Hein ? Attends, ça fait combien de mois ? Pardon ? Allez-y, c'est quoi les tendantes que vous connaissez ? Les tendantes de l'épaule. Les muscles.

Les tendantes, là-dedans, c'est... Bon, je l'ai dit garde. C'est quoi ça ? C'est indiqueur. Je veux les tendres.

La longue portion de visseuse. La longue portion de visseuse, il part ici. La croix, la longue

portion qui descend, qui est intra-articulaire.

D'accord ? Ce n'est pas en totale. Qui dit ? La croix de montateur. Vous me dites un peu, voyez-vous.

Supra-épineux, intra-épineux, supra-épineux, platineux. Terminé. Subscapulaire.

Si vous dites subscapulaire, c'est différent, d'accord ? Subscapulaire. Supra-épineux. Supinatus.

Supra, encore, sus, épineux. Terminologie. Intra, supra, intra, et ? Très bien.

On commence par l'articulation de l'épaule. Elle unit la clavicule. D'accord ? L'humérus.

L'os de l'humérus. Et le ? Le scapula. Le scapula.

On en a parlé de la cordure, on a parlé de la tête. On a parlé de la surface articulaire de la tête et de la surface de la clavité. Il est lui-même, s'il est recouvert et il est un peu agrandi par le bourreau de la droite, il reste très petit par rapport.

C'est le 1 tiers qui est recouvert, d'accord ? Il est aidé par cette capsule. La capsule. La capsule qui est épaisse, qui essaie de lutter contre la masse faible, d'accord ? Et du fait de sa complexe, c'est elle qui permet les mouvements dans les 3 points de la circonvulsion.

D'accord ? Alors, vous voyez là l'acromion avec le ligament acromio-coraco acromial qui fait pour la coiffe qui va venir ici qui fait le reteu de protection. C'est comme une auvent au-dessus de la tête humérale. Vous voyez la bourse.

La bourse sous acromio, les tubiquettes. Toutes les bourses ont la même structure. Ce sont 2 feuillets qui sont à l'état normal.

D'accord ? Il n'y a pratiquement pas d'épanchement. Il y a une petite viscosité qui va permettre qu'ils ne se collaborent pas. Ce n'est qu'en état pathologique qu'il va y avoir un épanchement.

C'est ce qu'on appelle la bursite. D'accord ? La coiffe des rotateurs qui peut nous dire pourquoi il y a cette nomination. Pourquoi la coiffe et pourquoi les rotateurs ? Oui.

Très bien. Pourquoi du coup il vient coiffer la tête humérale ? Les rotateurs parce qu'ils participent tous à la rotation. Les 4 tendons participent à la rotation externe.

Il n'y a qu'un seul qui participe à la rotation interne. Lequel ? Très bien. C'est le subscapularis qui est responsable de ce groupe.

Le seul rotateur interne. Le reste participe à la rotation externe. D'accord ? Alors vous reconnaissez le muscle supraspinatus.

La frappe accessoirement au petit ventre. Et voilà. C'est du fleux.

Ce dernier où ? Le ? Le ? Le ? Le ? Montre en l'ordre. Non c'est le feu. D'accord.

Alors il y en a 34. Il y en a 38. Alors seul le subscapularis qui se termine sur le troquin.

Je vous aide même à la donner. Subscapularis. C'est lui.

Subscapularis. Voilà. Il est là.

Il l'arrange. Il vient de l'intérieur. Il l'arrange.

Là l'omoplate. La face antérieure de l'omoplate. Et regardez.

Il vient se terminer sur le troquin. Les autres se terminent tous sur le tropique. Le supra en haut et ils sont tous un au-dessous, au-dessus de l'autre.

D'accord ? C'est très important. Pourquoi ? Pourquoi il faut connaître les points d'insertion ? En cadre. Pour localiser Le patient me dit s'il y a un problème c'est à l'endroit où vous êtes.

Hein ? Vous voulez continuer ? Je n'ai pas de problème. Premier avec l'isme. Deuxième vous sortez.

Alors qu'est-ce qu'on disait ? Il faut savoir localiser. On ne cherche que ce qu'on connaît. Si je ne connais pas, si je sais, je ne sais pas.

L'insertion du tendon ne peut pas me rater. D'accord ? Très bien. Le subscapularis seul se termine sur le troquin.

Les autres se terminent sur le tropique. Voici ce que donne finalement. C'est pourquoi on l'appelle coiffe.

Il coiffe la tête et regardez le complexe acromion ligament qui est l'ouvrant de protection. Or, l'acromion est ce guidon qui est très épais. D'accord ? A un moment donné, il va constituer une source de danger.

Parce qu'on commence avec des tendons qui sont très épais mais on finit avec l'âge et la surutilisation. Ils vont se dégrader comme tout autre chose dans notre organisme. Il va y avoir une dégénérescence dégénérescence graisseuse.

Entre les fibres qui étaient très épais, il va y avoir surintéresse. Le tendon va se fragiliser avec le temps. Et puis, il va y avoir rapidement le patient fait une échographie et on parle de rupture.

On parle de fissure. Il va vous dire, je ne me suis jamais tendu. Je n'ai jamais eu d'accident de la voie publique.

Mais c'est dû à cette fragilité. La tendinopathie est due à quoi ? Quand j'ai mal à l'épaule, quand

je fais ces mouvements en bas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander ça autour d'eux.

Ce n'est que lorsque je vais faire une élévation de mon épaule que je vais avoir mal. Pourquoi ? Parce que une rotation finalement qu'est-ce que je vais faire ? C'est la mise de contact de la poisse avec ce ligament et cet acromion. C'est ce qu'on appelle la zone de conflit.

D'accord ? Si vous attendez que le patient vous entende que le patient a un conflit sous acromion c'est de s'apprendre. D'accord ? Ici, les mouvements il n'y a pas de problème. Il peut faire ça, il peut faire ça.

Mais dès qu'il va y avoir le contact de la poisse avec l'acromion il va déclencher la douleur. C'est ça, le conflit sous acromion. Alors, une épaule douloureuse est un motif très fréquent de constipation.

Les étiologies sont nombreuses. Dans 95% des cas il s'agit de pathologie abarticulaire. Abarticulaire ça veut dire que on est autour de l'articulation et ça veut dire l'étendue.

Une douleur de l'épaule égale une tendinopathie jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Dans 5% des cas, il peut s'agir de toutes les pathologies dont on a parlé hier. De l'arthrose, de l'arthrite septique.

L'arthrite septique maintenant on sait tous de quoi on parle. C'est un genre. C'est une arthrite liée à un genre, que ce soit une bactérie, un virus ou autre.

Ou bien rhumatismale, ça veut dire mon épaule, l'arthrite, rentre dans un cadre de rhumatisme inflammatoire chronique ou bien il peut s'agir de ce qu'on appelle l'arthrite métabolique, notamment comme la goutte dont on a parlé hier. L'examen commence toujours par l'inspection d'un patient et d'un médecin. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'inspection ? Qu'est-ce que je peux voir dans l'inspection ? Une infection.

Une infection qui peut être au niveau de l'articulation, au niveau des muscles, Oui, les signes inflammatoires, la chaleur, c'est par la palpation. Je peux voir l'accumulation et la rougeur. L'améotrophie, très bien, au contraire, je peux avoir l'accumulation et l'améotrophie.

Très, très bien. C'est le signe de l'épaulette. En cas de l'infection, c'est l'épaulette.

C'est comme le monsieur qui a un symptôme de l'épaulette. D'accord ? Excellent. Voici quelques exemples.

D'accord ? Regardez l'articulation. Comment il est. Augmenté de taille.

L'améotrophie, par rapport à l'autre. Regardez. L'infraspinatus par rapport à celui de l'autre.

Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attitude du membre traumatisé. C'est le patient qui a mal. Il a une lourdeur.

Lourdeur qui est douloureuse. Et il se repose soit en mettant l'avant-bras par la main soit en mettant l'avant-bras par la main et il se repose. La mobilité, qu'en cherche-t-il ? Deux.

La mobilisation. Passive. Et la mobilisation ? Active.

Alors, maintenant, je suis le malade. Qu'est-ce que tu dois me demander de faire ? Je viens vous voir. J'ai une douleur de l'épaule droite.

Alors, qu'est-ce que tu vas me demander de faire ? Comment ? Je ne sais rien. Montre-moi. C'est quoi ? Tu le mets ça.

Comment on appelle ça ? C'est quoi le mouvement de l'épaule ? Montre-moi l'endépluche. La rétropuche. Il est ? À combien de degrés ? 180.

120, 180 ? 180. Si je vous dis que vous êtes tous les deux, vous avez vraiment tous les deux l'origine, ça va être très, très bien. Parce que la mobilité propre à l'articulation, c'est 120.

Si je vais, si quelqu'un me bloque le scapulaire, je ne peux pas aller plus de 120. Je peux être, je peux aller à 180 par la bascule. Faites des exercices.

C'est la bascule de votre omoplate qui permet l'ouverture complète de mon épaule. Très bien. Ça c'est l'endépulsion.

Quoi d'autre ? L'endépulsion d'exercice. La rétropuche. Montre-moi la rétropuche.

C'est l'élévation en arrière. Combien ? Combien vous avez ? Quoi d'autre ? L'abduction. L'abduction et l'abduction.

Montrez-moi l'abduction. Vous dormez. Bien.

Allez-y. Allez-y. Très bien.

Ça c'est l'abduction. L'abduction c'est l'élévation sur le côté. Pareil.

L'endépulsion et l'abduction c'est à l'intérieur de mon corps. Les rotations. Bien.

Pardon. Pardon. Rotations externes et rotations internes.

Vous avez les images de mon corps. Rotations externes. Comment je fais ? Oui.

Bien commencer. Bien. Très bien.

Alors. Mon bras, avant-bras, il est à combien ? 80°. 80°.

D'accord. Je bloque le côté et je fais sortir l'avant-bras vers l'extérieur. Rotations externes.

Il est à combien ? Est-ce que je peux arriver à 90° ? 80°. Il faut... Ne riez pas. Je ne vais pas vous dire que la mobilité est anormale.

Je vais vous dire que la rotation externe est à 85°. C'est à vous de décider. Est-ce que l'angle de mouvement est normal ou anormal ? Je vous ai l'apport.

Bien. Rotations internes. Le coude derrière.

La même chose. C'est le coude bloqué en arrière. La rotation, n'oubliez pas que je rote quoi ? C'est la tête.

Tout à l'heure, comment elle fait au sein de l'angle de mouvement ? Elle sort. C'est la rotation externe. Maintenant, je rote complètement mon épaule, mon bras vers le dos.

D'accord ? En avance. La palpation. Voici la palpation.

La palpation, c'est rechercher la chaleur. Toujours chaleur. Rechercher les points douloureux.

D'accord ? La mobilité, on en a parlé. Il y a la rétropulsion. Elle est de 0 à 50°.

L'amplification de 0 à 180°. L'abduction. L'abduction.

Les rotations. La rotation externe, 80°. Rotation interne, 95°.

D'accord ? Est-ce que vous imaginez un patient qui a très mal à l'épaule et moi, je vais lui demander de faire ça. Est-ce qu'il va être capable de faire ça ? C'est très douloureux. Moi, il cherche le soulagement.

Il va sortir très douloureux. C'est pourquoi on pense à ce qu'on appelle des mouvements combinés. Ça veut dire je peux lui dire de faire deux mouvements.

Je vais déduire tous les mouvements dont on a parlé. Le premier, de placer la pointe de la main sur la nuque. Qu'est-ce que je teste ? L'abduction, rotation externe et rétro.

Plus ou moins rétro. D'accord ? Le dos de la main, je vais lui demander de faire le dos sur le dos. Rotation interne, rétropulsion et abduction.

D'accord ? C'est ce qu'on appelle, au lieu de faire six mouvements, je fais deux mouvements. Et quand il est très limité, il ne peut rien faire avec quelques degrés. C'est ça, je ne vais pas m'amuser à lui demander de faire ces acrobaties.

On est bien d'accord ? Alors, on en a parlé hier. Maintenant, notre malade. Il a mal à l'épaule.

Je lui ai demandé de faire les mouvements combinés. Il est douloureux. Si je vous dis anormal,

ça veut dire soit que c'est douloureux, soit que c'est limité dans le mouvement.

Ça, ça ronge. Anormal, ça ronge, ça veut dire qu'il n'est pas normal. Alors, on ne s'est ronglé pas que, au moins, il ne peut pas.

C'est-à-dire que tous les mouvements, il ne peut pas. Je vais le tranquilliser, je vais prendre les précautions, ne pas augmenter la douleur. Et je vais examiner, je me rends compte que, effectivement, tous les mouvements sont douloureux et limités.

Et, ou, limités. On est devant le premier tableau. Ça veut dire qu'on est devant la mobilité active anormale, mobilité passive anormale, encore plus.

C'est un problème de l'articulation. C'est l'articulation qui a mal. D'accord ? Maintenant, activité, mobilité active anormale, mais moi, quand j'ai fait ma mobilisation, je me rends compte qu'il est tout à fait normal.

Je conclus. C'est un problème tendue. C'est une tendinopathie jusqu'à preuve du contraire.

D'accord ? Maintenant, toutes les mobilités sont normales. Il a mal, il sent la douleur ici, il fait bizarrement, j'arrive à faire tous les mouvements. Moi aussi, quand je fais mon examen, l'articulation n'est pas réelle, il n'y a pas de douleur.

Il faut chercher ? Il faut chercher ailleurs ce qu'on appelle la douleur projetée ou la référence. C'est bon ? C'est trois tableaux, c'est bon ? Anormale, anormale, c'est l'articulation. Anormale, normale, c'est une tendinopathie.

Si vous voulez, vous sortez. Vous dérangez. Vous dérangez.

Vous ne voulez pas suivre. Alors, normale, normale, il faut chercher ailleurs cette douleur projetée ou référence. Maintenant, on est dans le cas où on a suspecté une tendinopathie.

C'est là où on va passer à la mobilisation, ce qu'on appelle contrariée. Qu'est-ce que vous comprenez ? Contrarié. Contre l'existence.

Vous, j'écoute. Contre quoi ? Très, très bien. Ça se trouve dans quoi ? On est parti d'un problème, un ensemble de problèmes.

Attention. Je n'ai pas une tendinopathie. D'accord ? Alors, je passe à la contrariée.

Pourquoi ? Pour voir combien on a de tendons. On aurait 4 à 5 tendons. Il faut que je m'oriente de quel tendon il s'agit.

C'est pourquoi je dois tout d'abord connaître l'action du tendon que je cherche. Je vais demander au patient de faire le mouvement que fait le suprasépineux. Le suprasépineux, qu'est-ce qu'il fait ? Quels mouvements auxquels je vais m'opposer ? On regarde à l'anatomo, l'incitoyen que vous

avez oublié.

Alors, tendinopathie, premièrement, avant de passer à la spécialisation quel tendon, est-ce que vous vous rappelez du conflit ? Je vais, première étape, c'est quoi ? Je dois chercher est-ce qu'il y a un conflit ? Et le conflit, si vous vous rappelez, quand est-ce que je peux l'avoir ? C'est en préalable, c'est en élevant mon épaule qu'il soit au contact de l'auvent de protection des droits lacromiant et libéral. Il y a ces trois manœuvres. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les noms de l'équipe.

Ayez ça dans la tête parce que les cliniques, il y a une station pour la preuve des remadeaux. Et les gens qui sont passés par la remadeau en E, c'est chance d'avoir ça en pratique, ceux qui ne sont jamais passés par ces services en U0. D'accord ? C'est pourquoi j'assiste.

Malheureusement, nous n'avons pas de télé. Je suis là pour vous aider. D'accord ? Le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est trois manœuvres pour chercher le corps.

Premier, le nid. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est une c'est une antépulsion passive. C'est le médecin qui fait ça.

Il maintient le scapula. D'accord ? Vous imaginez que si j'ai mal, je l'abaisse. D'accord ? Ah oui, là, je peux continuer avec la douleur.

La douleur n'est pas très importante. Alors ça, c'est le premier qui est tout simple. C'est le nid.

C'est une antépulsion passive à laquelle je vais résister. Le deuxième, c'est le hooking. Hooking, qu'est-ce qu'il fait ? C'est une Le bras, il fait 90 avec l'avant-bras et il est au même plan de mes épaules.

C'est sûr, je dois arriver à l'arc douloureux. D'accord ? C'est pourquoi la douleur, qu'ils soient alliés, il est très important. D'accord ? Et, pour le retenir, l'avant-bras et mon corps constituent un hache avec lequel commence le hooking.

D'accord ? Pour les gens qui ont un conflit, c'est impossible qu'ils font ça. C'est impossible. Ils ne peuvent pas faire ça.

Amusez-vous à faire ça. On peut trouver des surprises. Le Yukon.

Le Yukon. Qu'est-ce qu'il fait ? Les animateurs. C'est les bras douloureux.

Il demande au patient de mettre la main sur l'épaule contralatérale. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a aussi le bras et l'avant-bras. C'est un Y. D'accord ? C'est le Yukon.

Il va lui demander de faire une élévation du coude à laquelle il va s'opposer. D'accord ? Très bien. Combien il y a de manœuvres ? Il y en a trois.

Le principe est simple. C'est de reproduire la douleur en venant avec le bras douloureux. D'accord ? Un, deux, trois.

Le mire, c'est le plus simple. C'est dans l'impulsion. Le Hoki, mon avant-bras, constitue un H avec le corps et le Yukon.

Mon bras et mon avant-bras, un Y en posant la main sur l'épaule. D'accord ? Je vais demander au patient de faire une élévation du coude à laquelle je vais m'opposer. C'est bon ? C'est une très bonne question.

Si le malade est très douloureux, le malade est déjà douloureux, le coude est déjà douloureux. D'accord ? Là, on parle des petites endylopathies. Dans les cas où on a un doute sur l'endroit, on n'arrive pas à faire la part.

Est-ce que c'est une des bras les plus souples ? D'accord ? Maintenant, on est sûr qu'il y a un conflit. Il y a le conflit. C'est là où on va passer à la spécification.

Quel tendon est léger ? Quel tendon libère l'inflammation hors de la fissure ? D'accord ? C'est ce qu'on appelle la mobilité contrariée spécifique. Alors, pour le supraépineux. Supraépineux, on a dit qu'il participe à la rotation extérieure.

C'est lui l'élévateur principal de l'épaule. C'est pourquoi je vais demander au patient qui est devant moi de faire une élévation de son bras bien tendu avec le corps. Le pouce en bas.

C'est ça la rotation. Le pouce en bas. D'accord ? Mon bras était dans le plan avec le même plan de mon corps.

Je vais lui demander de faire une translation vers l'avant. J'étais là sur le même plan. Translation de 30 degrés tout en maintenant le pouce en bas.

Et 90 rasnis. Je dois être dans l'arc douloureux. Et je vais faire une pression à laquelle je vais m'opposer.

Je vais lui demander de faire une élévation à laquelle je vais m'opposer. Si c'est douloureux, ce n'est pas possible. C'est le supraépineux jusqu'à preuve du contraire.

Vous allez à la consultation et vous disent que le suspect s'est rendu au passé du supraépineux. C'est par ce mouvement. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le jog.

Le pas après, c'est pour la langue pour cent de biceps. La langue pour cent de biceps, il est complètement antérieur. Elle passe dans la coulisse bicipitale.

C'est pourquoi c'est lui qui assure l'élévation antérieure. D'accord ? Comment je fais tout le temps ? Mes principes. Élévation.

Devant moi. L'arc douloureux. Je dois être dans l'arc douloureux.

La corde pâle. De ma main vers le haut. Je vais lui demander une façon de faire une élévation à laquelle je vais m'opposer.

C'est la langue pour cent de biceps. L'hépaté. C'est pour l'intraépineux.

L'hépaté, je peux faire simplement ce que fait l'infraspinatus. Et je demande au patient de faire la rotation à laquelle je vais m'opposer. D'accord ? On va voir ça sur les volontaires.

Rotation extérieure à laquelle je vais m'opposer. Même chose pour le subscapularis. Je demande au patient de faire une rotation extérieure.

La rotation extérieure à laquelle je vais tenir la main. Regardez maintenant. Je vais tenir la main loin de mon dos.

Loin de mon dos, je vais lâcher. Je vais lâcher de façon brusque. S'il y a une atteinte, le patient va faire ça.

C'est-à-dire qu'il est faible. D'accord ? Si l'atteinte est très importante, il ne peut même pas faire ça. C'est impossible de faire la rotation extérieure.

D'accord ? Ce que je peux avoir des volontaires, c'est qu'avant de passer... .. Alors, supposons qu'il a mal au niveau de l'épaule droite, on commence par quoi ? Alors, il commence par l'inspection. Bien, on a passé l'inspection, on va passer à la mobilité, la mobilisation. Oui, c'est elle, de façon absolue.

Alors, de mettre la pointe là, vers la pointe, c'est ça, c'est la forme de la relation avec l'autre. Pas de douleur. Très bien.

Deuxième, dos de la main dans le dos, il n'a pas mal. Très bien. Alors, la mobilité est active, il est tout à fait normal.

Bien, supposons qu'il est anormal. Pour passer. Il n'y a pas de souci de dire le contraire, il y a le souci de dire.

C'est les signes, les signes de conflit. J'ai un peu. Oui.

Voilà, ok. Est-ce qu'il y a plus de douleur ? Voilà. Ça c'est le test de lire, c'est l'enregistrement.

Très bien. C'est dur. La pointe en haut.

La pointe parfaite. La pointe parfaite. Le haut.

Le haut. En Y. C'est un Y. Non, c'est pas un Y. Il est dans son rêve, à laquelle tu vas t'opposer. C'est une présence naturelle.

Et bien, c'est le malade qui est plus puissant qu'eux. Bien. Alors maintenant, on a les signes de conflit qui sont tangibles.

On passe au test de spécifique. Supra-élimineux. Très bien.

Lisez là. C'est le pouce en bas. Vous pouvez voir, s'il vous plaît.

Regardez, s'il vous plaît. Le bras à 90 degrés du corps. Le pouce en bas.

Translation vers le devant de 30 degrés. Ça, c'est le mouvement. Et tu vas lui demander de faire une petite surélévation.

Supra-élimineux. D'accord ? Je vais lui demander de faire une surélévation à laquelle je vais m'opposer. Supra-spinalus.

Non conscient. Je prends pas de main. Oui.

Comme de la main en haut. Demain, ça, je vous ai dit, il y a pas de problème. Il y a la physique, là.

Il y est. Voilà. Ça va, il n'y a pas de problème.

Ça, c'est la langue pour ça. Qu'est-ce qu'il reste ? L'infra-épineux. L'infra-spinatus.

L'infra-spinatus, c'est un des deux mouvements. Mais il fait chez les loins, les loins douloureux. Alors, faites-le en rotation.

Coude collée. Toujours, n'oubliez pas le coude collé. Parce que ça, ça devient normal.

Ça devient plus facile. Coude collée au corps. D'accord ? Et il va faire une rotation dans la tête.

Coude posée. Très bien. D'accord ? Off test.

C'est pour le subscapularis. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Elle va s'opposer. Je le fais.

D'accord ? Je mets le pied à l'avant. Je mets le pied à l'arrière du second. Et je fais l'assaut.

Normalement, il y a une petite résistance. Le muscle, quand il est normal et tendant, il y a la résistance. Que si on le fait sur une surface très faible, elle tombe.

Vous sentez ? Il tombe. C'est bon ? Merci beaucoup. Vous voulez faire un autre test ? Vous laissez le bras.

Très bien. Alors, les douleurs projetées. Ce n'est qu'une répétition.

Je peux avoir une douleur qui irradie d'une colique hépatique, d'un infarctus, d'une pathologie

pulmonaire pleurale, d'une douleur sphénique, ou d'une névralgie cervicobrachiale. C'est simple. Pourquoi c'est simple ? Parce qu'il se termine sur le moyen de l'épaule.

Je peux avoir une douleur de l'épaule qui correspond à la douleur du nerf. Dans ce cas, la mobilisation passive et active sont normales. Ce ne sont pas douleurs.

Voilà le dernier diapo. Je le dois pour votre attention. Voici les 4 tableaux possibles pour les douleurs de l'école.

Il y a la douleur simple, et la tendulopathie, qui n'est pas très intense. C'est le patient qui n'a pas tout le temps mal. Il vous dit quand il fait ce mouvement, quand il fait ça, c'est la douleur qui traîne.

Ce n'est pas très intense. Il ne s'inquiète pas. Il est gêné.

Le volant, c'est une douleur qui est simple. C'est le tableau normal. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure.

La mobilité active va être anormale. Je le répète, ça peut être lié à la douleur. C'est la douleur où il y a la limitation.

Il n'y a que les deux. D'accord ? Mais la mobilité passée est normale. C'est du tendulopathie jusqu'à preuve du contraire.

Maintenant, il y a le vol hyper-agile. Si vous vous rappelez, le vol hyper-agile a une douleur supérieure à 8. Hyper-agile, il n'a pas de position. Antagile, il ne peut pas dormir.

Il ne peut pas dormir sur les deux côtés parce qu'il y a de la pression. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va voir ? La touche mondiale est impossible. La mobilité, après on va dire que c'est la douleur.

D'accord ? C'est hyper-agile. Alors, c'est très anormal, très limité. Il n'y a que l'articulation où les pieds ne paraissent.

C'est juste la douleur. La douleur liée à la limite, liée au mouvement. D'accord ? Ça fait très mal que la mobilité soit active ou passive et anormale.

D'accord ? Dans ce cas-là, ça peut être soit une fracture, soit une luxation, soit un problème rhumatismal, un problème métabolique ou bien sceptique. D'accord ? On est, si vous avez fait attention, on est dans mobilité active, active, anormale et mobilité passive, anormale. Ça veut dire que c'est moins d'articulation.

L'articulation, ça peut être mécanique ou elle inquiètera une poussée. Ça peut être inflammatoire, infectieuse, métabolique, rhumatismal, etc. En tout cas, ça peut être, vu la douleur très intense, un problème de luxation ou de fracture.

C'est compris ? Mais, n'oubliez pas que c'est anormal et bien. Maintenant, on est dans les points pseudo-paralytiques. Le patient qui vient avec le membre comme ça.

Je lui demande de mobiliser ses pieds. Non, non, non. Je ne peux pas faire ça.

C'est impossible. C'est impossible. D'accord ? Mais, je vais faire, je vais lui demander de la faire mobiliser par notre bain.

Il arrive. Qu'est-ce que vous déduisez ? Si c'était un problème articulaire, est-ce qu'il va arriver à faire le mouvement ? Le mouvement qu'il fait ou autrement, c'est synonyme à la mobilisation active. Et du coup, pas si pendant que je vais faire moi-même.

D'accord ? On est deux dans l'active. Impossible. Impossible.

Mais quand mon socle va venir, il va me dire. Non, non, non. Je n'arrive pas.

Et effectivement, ce n'est pas possible qu'il a fait bouger. Je vais lui demander de faire mobiliser par l'autre. Et tiens, il la mobilise dans tous les mouvements.

D'accord ? Ça, ça veut dire une rupture des tendons juste après du entraînement. Alors, neurologique, réponds-moi. Qu'est-ce que ça va chercher ? Quoi d'autre ? Oui.

Le fourmillement. Parce qu'on l'utilise en façon de palesthésie. D'accord.

Et puis, si tu as la lourdeur, à la lourdeur complètement, et que tu as l'attente, tu ne vas pas l'amuser à le mobiliser. Il faut rapidement l'acheminer, faire une IRF et au bloc. Parce que la paralysie nerveuse, c'est typique.

Ça veut dire que les problèmes sont sérieux. D'accord ? Ça sent de la lourdeur que je vous ai dit hier pour la maladie nerveuse. C'est ce que vous disent les patients.

Tu dis que tu as très la lourdeur. Mais mes chimistes prirent du vent. Il faut faire attention.

C'est votre maman qui vous dit la couverture et ne peut même pas faire remonter la couverture. Elle dit qu'il y a la lourdeur avec laquelle elle arrive à le mobiliser. C'est bon ? La lourdeur qui la contient ça veut dire que tu as une paralysie.

Bien. Est-ce que jusque là c'est bon ? Active anormale, passive normale, douleur simple. C'est une ongulopathie jusqu'à preuve du contraire.

Active impossible. C'est le tableau de l'épaule pseudo-paralytique. D'accord ? C'est une rupture dépendant jusqu'à preuve du contraire.

Maintenant, l'épaule en redis. Zéro. Zéro.

Ça veut dire qu'il est raide. C'est l'articulation. Soit c'est une arthrose évoluée, soit c'est une

atteinte mécanique ou inflammatoire.

Si vous vous rappelez, je le rappelle à votre avis, qu'est-ce qui permet la mobilisation dans les trois plans ? C'est la capsule. Il y a des moments, comme maintenant chez le diabétique, il y a un mécanisme où il va y avoir une rétraction. C'est-à-dire que la capsule qui était lâche, va être retravaillée.

Et puis, du coup, plus de mouvements. C'est ce qu'on appelle la capsule rétractive que font les gens après une chute. D'accord ? À ou là, très grand chez les diabétiques.

D'accord ? C'est très important. Vous trouvez toujours des difficultés. Alors que je ne cesse de répéter.

Est-ce que c'est compliqué ? C'est bon ? C'est bon ? Hyperalgique, c'est par la douleur. C'est par la douleur. Hyperalgique.

Vous avez l'habitude symbolique. Tu as tellement mal. Tu as tellement mal.

Tu ne veux même pas que quelqu'un te touche. C'est par rapport à la douleur. C'est possible.

Il n'est pas raide. D'accord ? Il est très anormal. Très douloureux.

Mais la mobilisation est possible. Il n'est pas raide. C'est la douleur qui limite les neurasthiques.

D'accord ? En réalité, c'est une chute et il est gelé. C'est bon ? C'est bon ? Avant de passer aux neurasthiques, deux volontaires.